SDD 122 Sujet n°1

Spécialité : Psychiatrie

Date : 12/11/2024
Auteur : Maëva Froger (DES Psychiatrie, EN 2024)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (DES MAR, EN 2024), Andres ESQUIVEL (DES Psychiatrie EN 2024)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 122
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	/

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes interne de médecine générale aux urgences et recevez Monsieur D, 43 ans, pour idées délirantes. Le psychiatre de garde est occupé avec un autre patient et vous commencez donc l'interrogatoire.

Constantes : TA 150/88, FC 92 bpm, Sat 99%, T°36,9

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Mener l'interrogatoire de ce patient
- Caractériser le délire
- Initier le bilan étiologique

Vous ne devez **PAS** :

- Examiner le patient
- Initier un traitement pharmacologique
- Poser un diagnostic

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
1.	Recueillir les antécédents médicaux et psychiatriques	1pt	☐
2.	Recueillir les traitements	1pt	☐
3.	Recueillir les toxiques (alcool, tabac, drogue…)	1pt	☐
4.	Reconnaître que le délire est sur un thème de **persécution et/ou mégalomanie**	1pt	☐
5.	Reconnaître que le délire est **non systématisé**	1pt	☐
6.	Reconnaître que le mécanisme est **hallucinatoire**	1pt	☐
7.	Reconnaître que le patient **adhère totalement** au délire (*aucune critique du délire par le patient*)	1pt	☐
8.	Reconnaître que le délire provoque **anxiété, inquiétude et/ou peur chez le patient**	1pt	☐
9.	Faire préciser le caractère aigu ou chronique des hallucinations	1pt	☐
10.	Rechercher un risque de passage à l'acte auto et/ou hétéro-agressif	1pt	☐
11.	Demander un bilan systématique, au minimum 3 éléments parmis la liste suivante : *glycémie, ionogramme, calcémie, NFS-plaquettes, CRP, bilan de coagulation, ECG, Alcoolémie, TSH*	1pt	☐

Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)	
1.	**1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair**

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

3.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un bu précis, approche intégrée

TOTAL (max 20 items)	14 points

Éléments de rétroaction :

Devant un patient délirant, l'urgence est de le sécuriser en le plaçant dans un environnement adapté et calme.
Par la suite, l'idée est de l'apaiser, comprendre ce qui l'amène puis d'initier un bilan afin d'éliminer une cause somatique (hypoglycémie, hypercalcémie, dysnatrémie, hyperthyroïdie etc…). Les constantes sont également nécessaires afin d'éliminer le caractère urgent d'une prise en charge.

La caractérisation du délire pourrait revenir à établir « l'histoire de la maladie ». C'est une notion purement « bête et méchante » mais qui permettait tout de même de réviser cette partie du cours. Pour ceux qui n'auraient pas l'astuce, retenir : ***TOMATE***

- *Thème : Mégalomanie, Erotomanie, Persécution, Jalousie*
- *Organisation : systématisé ou non (le délire est-il structuré ou bien part-il dans tous les sens ?)*
- *Mécanisme : Hallucinatoire, Interprétatif, Intuitif,*
- *Adhésion : nulle, partielle, totale*
- *Thymie / Émotions : anxiété, colère, tristesse etc..*

Comme toute « Histoire de la maladie », ne pas oublier de faire préciser ***depuis combien de temps cela dure****.*

Dans un ECOS de psychiatrie (mais aussi dans la vraie vie), ***TOUJOURS rechercher au moins le risque de passage à l'acte suicidaire +++*** mais aussi de de passage à l'acte hétéro-agressif notamment dans le cadre d'idées délirantes.

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes Monsieur D, 43 ans, vous vous présentez aux urgences puisque le FBI vous recherche car vous venez de trouver un nouveau traitement qui pourrait soigner toutes les maladies et ainsi sauver le monde.

Une voix dans votre tête ne cesse de vous dire qu'il faut vous cacher car ils vous veulent du mal. Vous ne vous sentez plus en sécurité chez vous de peur que vos proches soient de mèche et qu'ils vous retrouvent. Aucune critique des idées. Cette situation vous rend particulièrement nerveux.

Cela fait maintenant 1 semaine que tout a commencé.

Vous n'avez pas d'idée suicidaire. Vous ne voulez de mal à personne mais s'il faut vous défendre, vous le ferez.

Plan de la station ECOS :

Patient debout, agité

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

« *Il faut que vous m'aidiez à me cacher, je vous en supplie ! Il ne faut pas qu'ils me retrouvent si je veux sauver le monde.* »

Identité du patient :

Masculin, Monsieur D., 43 ans, 1m84 pour 79kg

Mode de vie :

Vous êtes biologiste dans un laboratoire pharmaceutique. Vous avez 2 enfants et êtes marié. Vous fumez un paquet de cigarette par jour et buvez un verre de vin le dimanche midi.

Comportement global :

Vous êtes agité (*impossible de rester en place*) et regardez systématiquement autour de vous. Attitude d'écoute (*maximum 10 sec*). Tremblements, gestes brusques. Absence de confusion.

Antécédents personnels :

Aucun antécédent médical ou chirurgical. Pas d'antécédent psychiatrique.

Antécédents familiaux :

Aucun

Médicaments :

Pas de prise de traitement au long cours.

Symptômes positifs :

Agitation, ne tient pas en place mais pas d'agressivité. Attitude d'écoute (=sujet semble ailleurs, distrait ou préoccupé).

Constantes :

TA 150/88, FC 92 bpm, Sat 99%, T°36,9

Donnée complémentaire :

/

Questions de relance :

Si au bout de 5min l'étudiant n'a toujours pas énoncé le bilan étiologique,
« Maintenant que je suis là, qu'est-ce que vous allez faire pour moi ? »